Protocolo institucional de higiene de manos y prevención de infecciones asociadas a la atención en salud

Clínica Santa Lucía · Código PR-SP-004 · Versión 3 · Área responsable: Comité de Infecciones y Seguridad del Paciente

Documento ficticio de capacitación. La Clínica Santa Lucía no existe. Este protocolo se escribió para demostrar la plataforma NuevaMente y se basa en las recomendaciones públicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre higiene de manos (estrategia multimodal y "Mis 5 momentos"). Las metas, los cargos y los procedimientos internos son inventados.

1. Objetivo

Establecer cómo, cuándo y con qué productos debe realizar la higiene de manos todo el personal que tiene contacto con pacientes o con su entorno, para reducir las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) y proteger tanto a los pacientes como a los trabajadores.

2. Alcance

Aplica a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapeutas, personal de laboratorio y de imágenes, estudiantes en práctica, personal de aseo y de alimentación, camilleros y cualquier persona que entre a las áreas asistenciales de la clínica. También aplica al personal contratista y a los proveedores que realicen mantenimiento dentro de las habitaciones.

3. Definiciones

- **Infección asociada a la atención en salud (IAAS):** infección que el paciente adquiere durante la atención y que no estaba presente ni en incubación al momento de su ingreso.
- **Higiene de manos:** cualquier acción de limpieza de las manos, ya sea por fricción con un preparado de base alcohólica o por lavado con agua y jabón.
- **Fricción con preparado de base alcohólica:** aplicación de un producto con alcohol sobre toda la superficie de las manos, frotando hasta que se seque. Es el método de elección cuando las manos no están visiblemente sucias.
- **Lavado de manos:** limpieza con agua y jabón, seguida de enjuague y secado con toalla desechable.

- **Zona del paciente:** el paciente y su entorno inmediato: la cama, las barandas, la mesa de noche, los equipos conectados a él y sus objetos personales.
- **Área de atención:** todo lo que está fuera de la zona del paciente dentro del servicio: el puesto de enfermería, los carros de medicamentos, otras camas y las superficies comunes.
- **Oportunidad:** momento en que existe una indicación de higiene de manos durante la atención. Se usa para medir el cumplimiento.
- **Tarea limpia o aséptica:** procedimiento que implica contacto directo o indirecto con mucosas, piel no intacta o un dispositivo médico invasivo, por ejemplo canalizar una vena, aspirar secreciones o curar una herida.

4. Los cinco momentos para la higiene de manos

La clínica adopta el modelo de los cinco momentos de la OMS. Cada momento corresponde a una situación en la que los microorganismos pueden pasar del área de atención al paciente, del paciente al trabajador o de una parte del cuerpo del paciente a otra.

Momento	Cuándo	Por qué	Ejemplo en la clínica
1. Antes del contacto con el paciente	Al acercarse al paciente, antes de tocarlo.	Protege al paciente de los gérmenes que el trabajador trae en las manos.	Antes de tomar la presión arterial o de ayudar a un paciente a sentarse.
2. Antes de una tarea limpia o aséptica	Inmediatamente antes del procedimiento.	Evita que entren gérmenes al cuerpo del paciente, incluidos los del propio paciente.	Antes de canalizar una vena, aplicar un medicamento ocular o curar una herida quirúrgica.
3. Después de la exposición a fluidos corporales	Inmediatamente después del riesgo de exposición y después de retirarse los guantes.	Protege al trabajador y al entorno de los gérmenes del paciente.	Después de tomar una muestra de sangre, cambiar un pañal o vaciar una bolsa de orina.
4. Después del contacto con el paciente	Al terminar de atender al paciente y alejarse de él.	Protege al trabajador y al área de atención.	Después de examinar al paciente o de ayudarlo a caminar.
5. Después del contacto con el entorno del paciente	Al salir de la zona del paciente aunque no se le haya tocado.	Las superficies cercanas al paciente también están contaminadas.	Después de cambiar la ropa de cama de un paciente que no estaba presente o de ajustar la velocidad de una bomba de infusión.

Una misma acción de higiene puede cubrir dos momentos al mismo tiempo. Por ejemplo, al pasar de un paciente a otro, la higiene de manos cuenta como momento 4 para el primero y como momento 1 para el segundo.

5. Qué método usar

5.1 Fricción con preparado de base alcohólica (método de elección)

Se usa en todos los momentos cuando las manos no están visiblemente sucias. Es más rápida, está disponible en el punto de atención y es mejor tolerada por la piel que el lavado repetido. La fricción completa dura entre 20 y 30 segundos.

1. Depositar en la palma una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las superficies de las manos.
2. Frotar las palmas entre sí.
3. Frotar la palma derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.
4. Frotar las palmas entre sí con los dedos entrelazados.
5. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.
6. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma derecha, y viceversa.
7. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma izquierda con un movimiento de rotación, y viceversa.
8. Esperar a que las manos estén secas. En ese momento las manos son seguras.

5.2 Lavado con agua y jabón

El lavado completo dura entre 40 y 60 segundos. Es obligatorio en estos casos:

- Cuando las manos están visiblemente sucias o manchadas con sangre u otros fluidos corporales.
- Después de usar el baño.
- Cuando hay exposición confirmada o sospechada a microorganismos que forman esporas, por ejemplo durante un brote de *Clostridioides difficile*. El alcohol no elimina las esporas.

Pasos: mojar las manos, aplicar jabón suficiente, frotar todas las superficies con la misma secuencia de la fricción (pasos 2 a 7), enjuagar con agua, secar completamente con una toalla desechable y usar esa misma toalla para cerrar el grifo.

No se debe usar el preparado de base alcohólica inmediatamente después del lavado con agua y jabón: no aporta beneficio y aumenta la irritación de la piel.

5.3 Higiene de manos quirúrgica

El lavado o la fricción quirúrgica antes de entrar a un procedimiento en salas de cirugía tiene su propio protocolo (PR-QX-002) y no se describe en este documento.

6. Guantes y higiene de manos

El uso de guantes **no reemplaza** la higiene de manos. Los guantes pueden tener microperforaciones y las manos se contaminan al retirarlos.

- Realizar higiene de manos antes de ponerse los guantes cuando la indicación lo exige (por ejemplo, momento 2).
- Retirar los guantes inmediatamente después de la tarea y realizar higiene de manos (momento 3).
- Cambiar de guantes entre un paciente y otro, y también al pasar de una zona contaminada a una limpia del mismo paciente.
- No lavar ni aplicar alcohol sobre los guantes para reutilizarlos.
- Los guantes no están indicados para tareas sin riesgo de contacto con fluidos, como tomar la presión arterial en piel intacta, y su uso innecesario hace que se omitan oportunidades de higiene.

7. Cuidado de las manos y requisitos personales

- Uñas cortas, limpias y sin esmalte en las áreas de atención directa.
- Prohibidas las uñas artificiales y las extensiones para el personal que atiende pacientes.
- No usar anillos, relojes ni pulseras durante la atención: impiden frotar bien y acumulan microorganismos.
- Mangas por encima del codo durante procedimientos.
- Usar la crema humectante que suministra la clínica al final de la jornada para prevenir la dermatitis. Una piel irritada se contamina más y lleva a que el trabajador evite la higiene.
- Si aparecen lesiones o irritación persistente, informar a Seguridad y Salud en el Trabajo para recibir un producto alternativo.

8. Estrategia multimodal de la clínica

Siguiendo a la OMS, la clínica aplica cinco componentes al mismo tiempo, porque ninguno funciona por sí solo:

1. **Cambio del sistema:** dispensadores de preparado de base alcohólica en cada punto de atención (a la entrada de cada habitación y al pie de cada cama en la unidad de cuidados intensivos), lavamanos con agua, jabón y toallas desechables en cada servicio.

2. **Formación:** curso de inducción obligatorio para todo el personal nuevo y actualización anual. El curso se dicta en la plataforma de capacitación de la clínica.
3. **Evaluación y retroalimentación:** observación directa del cumplimiento cada mes en cada servicio y entrega de los resultados a los equipos.
4. **Recordatorios en el lugar de trabajo:** carteles de los cinco momentos y de la técnica en cada punto de atención.
5. **Clima institucional de seguridad:** la dirección participa en las campañas, y los pacientes y sus familias pueden recordar con respeto a cualquier trabajador que realice la higiene de manos.

9. Medición del cumplimiento

Los observadores son enfermeras entrenadas por el Comité de Infecciones. Observan sesiones de máximo 20 minutos sin interferir con la atención y registran cada oportunidad y si hubo o no acción de higiene.

Fórmula: cumplimiento (%) = acciones de higiene realizadas ÷ oportunidades observadas × 100.

Una acción que se realiza sin que exista una indicación no cuenta como acción ni como oportunidad. Una oportunidad sin acción cuenta como incumplimiento aunque el trabajador use guantes.

Indicador	Meta institucional	Frecuencia
Cumplimiento global de higiene de manos	≥ 85 %	Mensual por servicio
Cumplimiento del momento 1	≥ 80 %	Mensual
Dispensadores con producto disponible	100 %	Ronda semanal
Personal nuevo con curso de inducción aprobado	100 % antes del primer turno	Por ingreso

Ejemplo: en una sesión en hospitalización se observan 40 oportunidades y 31 acciones de higiene. El cumplimiento es 31 ÷ 40 × 100 = 77,5 %, por debajo de la meta. El servicio debe revisar con el Comité las causas (por ejemplo, dispensadores lejos de la cama) y definir un plan de mejora en un plazo de quince días.

10. Responsabilidades

- **Todo el personal:** cumplir los cinco momentos, mantener los requisitos personales y reportar dispensadores vacíos.

- **Jefes de servicio:** garantizar insumos, liberar tiempo para la formación y analizar los resultados con su equipo.
- **Comité de Infecciones y Seguridad del Paciente:** actualizar este protocolo, formar a los observadores, consolidar los indicadores y presentarlos a la dirección cada trimestre.
- **Servicios generales:** recargar dispensadores y toallas, y mantener los lavamanos en funcionamiento.

11. Errores frecuentes

- Creer que usar guantes evita la higiene de manos.
- Omitir el momento 5 porque "no se tocó al paciente".
- Secar el alcohol con una toalla o agitar las manos antes de que se evapore: hay que frotar hasta que se seque solo.
- Aplicar poco producto, lo que deja zonas sin cubrir, sobre todo los pulgares y la punta de los dedos.
- Tocar el celular, la historia clínica o la cortina después de la higiene y antes de tocar al paciente: hay que repetir la higiene.

12. Glosario rápido

IAAS: infección asociada a la atención en salud. **Punto de atención:** lugar donde coinciden el paciente, el trabajador y la atención que implica contacto. **Preparado de base alcohólica:** producto para fricción de manos con alcohol. **Oportunidad:** indicación de higiene registrada durante la observación. **Esporas:** formas resistentes de algunas bacterias que el alcohol no elimina.

13. Referencias

Organización Mundial de la Salud. *Guía de la OMS sobre higiene de manos en la atención de la salud: resumen*, 2009. Organización Mundial de la Salud. *Manual técnico de referencia para la higiene de las manos*, 2009. Este protocolo es un resumen ficticio con fines de capacitación y no reemplaza esas guías.